UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

Département de Pédagogie

(Pédiatrie)
(Ictère chez le nouveau né)
sans patient
sans geste clinique

Nom du rédacteur : Morgane Gode-Henric **Date de rédaction : 28/11/2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire : (nom prénom)

Relecture et validation COPIL :

Situation de départ N°48 – Ictère chez le nouveau né

Domaine de compétence principal (en sélectionner 1 SEUL) : Stratégie de prise en charge

Domaine de compétence secondaire (en sélectionner 1 SEUL) : Stratégie diagnostique ;

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Chercher et hiérarchiser les signes anamnestiques et cliniques orientant vers un ictère pathologique

2- Différencier un ictère à bilirubine libre d'un ictère à bilirubine conjuguée et prescrire les explorations adaptées pour l'enquête étiologique

Objectifs de la station (items de connaissances abordés) :

1. ictère
2.

Patient simulé nécessaire à la station :NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- Résultats biologique donné par l'examinateur une fois que celui ci annonce le bilan/examen demandé

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne dans le service de néonatologie et vous êtes appelé pour Jules (J0-4h de vie) présentant un ictère couvrant l'entièreté de son corps et un examen neurologique anormal. Il est né à 36 SA et présente depuis ses 3h de vie cet ictère. La mère n'a pas réalisé avec application son suivi de grossesse (aucun examen d'imagerie ou biologique n'a été réalisé).

L'externe qui a vu le patient dès l'apparition de l'ictère a prescrit un dosage de la bilirubine et voici sa conclusion : ictère à bilirubine libre.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. **Énoncer** facteurs de risque propre à Jules et orientant vers un ictère pathologique grâce aux données de l'énoncé
2. **Prescrire** les explorations adaptées à la recherche étiologique
3. **Analyser** les résultats de l'exploration ET **évoquer** votre principale hypothèse diagnostique concernant l'étiologie de l'ictère

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Énonce la présence d'une prématurité - Cocher fait si : Age gestationnel < 38 SA OU prématurité OU naissance à 36 SA	
Enonce l'apparition précoce de l'ictère - cocher fait si : Ictère apparu avant 24h de vie OU ictère apparaît à 3h de vie OU apparition précoce de l'ictère	
Énonce la présence d'un l'ictère intense - cocher fait si : ictère intense OU ictère couvrant l'entièreté du corps OU ictère de la tête au pieds	
Énonce la présence d'un examen neurologique anormal	
Tache 2	
Prescrit Groupe sanguin - cocher fait si : Prescription du groupe sanguin de la mère ET du nouveau né	
Prescrit un Test de Coombs direct chez le nouveau né	
Prescrit une NFS chez le nouveau né	
Prescrit des Réticulocytes chez le nouveau né	
Tache 3	
Énonce la présence d'une anémie régénérative macrocytaire - cocher fait si présence des 3 termes : anémie régénérative macrocytaire	
Énonce la présence d'un test de Coombs positif	
Énonce le diagnostic étiologique : - cocher si présence de tous les termes : Allo immunisation (érythrocytaire) materno-foetale	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	1 à 5

UTILISER IMPERATIVEMENT DES VERBES d'ACTION ex : « Dit » « Énonce » « Palpe » « Écoute »
SEPARER CHAQUE ITEM (ex : « recherche une consommation de tabac » et « quantifie une consommation de tabac » sont deux items différents)

MAXIMUM 15 Items de compétence spécifiques et 5 items de compétences génériques
Choisir les plus pertinents/discriminants

Fournir des schémas pour les points cliniques à évaluer par l'examinateur (cadrans d'examen abdominal, foyers d'auscultation etc.)

Préciser quand l'examinateur doit intervenir pour donner un signe clinique positif

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Énonce la présence d'une prématurité - Cocher fait si : Age gestationnel < 38 SA OU prématurité OU naissance à 36 SA	
Enonce l'apparition précoce de l'ictère - cocher fait si : Ictère apparu avant 24h de vie OU ictère apparaît à 3h de vie OU apparition précoce de l'ictère	
Énonce la présence d'un l'ictère intense - cocher fait si : ictère intense OU ictère couvrant l'entièreté du corps OU ictère de la tête au pieds	
Énonce la présence d'un examen neurologique anormal	
Tache 2	
Prescrit Groupe sanguin - cocher fait si : Prescription du groupe sanguin de la mère ET du nouveau né	
Prescrit un Test de Coombs direct chez le nouveau né	
Prescrit une NFS chez le nouveau né	
Prescrit des Réticulocytes chez le nouveau né	
Tache 3	
Énonce la présence d'une anémie régénérative macrocytaire - cocher fait si présence des 3 termes : anémie régénérative macrocytaire	
Énonce la présence d'un test de Coombs positif	
Énonce le diagnostic étiologique : - cocher si présence de tous les termes : Allo immunisation (érythrocytaire) materno-foetale	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à faire la synthèse des données	Echelle de 1 à 5

BILAN BIOLOGIQUE DE JULES

Leucocytes	10000	/mm^3	norme proche de l'adulte
Hémoglobine	9	g/dl	moyenne Hb à la naissance = 16,5
VGM	130	fl	norme proche l'adulte
TCMH	29	pg	norme=> 26 - 35
CCHM	30	%	norme=> 28 - 35
Réticulocyte	600	G/L	norme => 200-400
Test de coombs	POSITIF		
Groupe sanguin	A+		

BILAN MERE

Groupe sanguin mère => O-